

EMT-1 自編教材概念練習

無解析版 | 題目頁不顯示答案，答案集中在最後

共 96 題 · 是非 0 題 · 選擇 96 題

列印時可指定題目頁範圍，不印最後的答案頁。舊制或條件衝突題另有標示；紙本攜帶請依當梯營區規定。

選擇題 96 題

001

站方自編，無考古題來源

依現行《救護技術員管理辦法》（民國 114 年 1 月 1 日施行）附表一，初級救護技術員（EMT-1）訓練課程的總時數為幾小時？

- (A) (A) 24 小時 (B) (B) 40 小時
(C) (C) 56 小時 (D) (D) 80 小時

002

站方自編，無考古題來源

依《救護技術員管理辦法》規定，初級救護技術員（EMT-1）合格證書之有效期限為幾年？

- (A) (A) 1 年 (B) (B) 2 年
(C) (C) 3 年 (D) (D) 5 年

003

站方自編，無考古題來源

依現行《救護技術員管理辦法》，初級救護技術員（EMT-1）於證書效期三年內應完成多少繼續教育課程，才得申請展延？

- (A) (A) 16 小時以上，其中 8 小時以上為指定模組之科目
(B) (B) 24 小時以上，其中 12 小時以上為模組二、四及六之科目
(C) (C) 32 小時以上，其中 16 小時以上為指定模組之科目
(D) (D) 40 小時以上，不限科目

004

站方自編，無考古題來源

依《救護技術員管理辦法》第13條規定，下列何者「屬於」初級救護技術員（EMT-1）得施行之救護項目？

- (A) (A) 靜脈注射生理食鹽水
(B) (B) 給予口服阿斯匹靈（Aspirin）
(C) (C) 氣管內插管（Endotracheal Intubation）
(D) (D) 使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）

005

站方自編，無考古題來源

救護人員施行救護所填具的「救護紀錄表」，依《緊急醫療救護法》第34條規定，應由救護車設置機關（構）及應診之醫療機構保存至少多久？

- (A) (A) 1 年
- (B) (B) 3 年
- (C) (C) 5 年
- (D) (D) 7 年

006

站方自編，無考古題來源

依《緊急醫療救護法》第14-2條，救護人員以外之人為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，法律上如何處理其責任？

- (A) (A) 僅免除行政責任，民法與刑法仍需負責
- (B) (B) 適用民法、刑法緊急避難免責之規定
- (C) (C) 若傷患不幸死亡仍需負過失致死罪責
- (D) (D) 僅限於直系血親施救時免責

007

站方自編，無考古題來源

救護技術員因業務而知悉或持有他人之秘密，無故洩漏者，依《緊急醫療救護法》第35條及第45條之罰則為何？

- (A) (A) 處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰
- (B) (B) 處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰
- (C) (C) 處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰
- (D) (D) 處新臺幣五萬元以上二十萬元以下罰鍰

008

站方自編，無考古題來源

依《緊急醫療救護法》第29條，救護人員應將緊急傷病患送達何處？

- (A) (A) 一律送往距離最近之醫學中心
- (B) (B) 送往傷病患指定之任何診所
- (C) (C) 送往就近適當之醫療機構
- (D) (D) 一律送往直轄市或縣市衛生局

009

站方自編，無考古題來源

依《緊急醫療救護法》第18條規定，救護車於救護傷病患及運送病人時，出勤人員的最低要求為何？

- (A) (A) 一名救護技術員獨自出勤即可
- (B) (B) 應有救護人員二名以上出勤
- (C) (C) 至少三名高級救護技術員
- (D) (D) 必須有一名急診專科醫師隨車

010

站方自編，無考古題來源

病患意識清醒且具有完全行為能力，但堅決拒絕救護人員處置與送醫，救護員第一步與標準處置應為何？

- (A) (A) 強制壓制病患並上約束帶強制送醫
- (B) (B) 不管病患立即收隊返隊離開現場
- (C) (C) 充分告知拒絕送醫之潛在生命危險，若仍拒絕，請病患或家屬簽署拒絕醫療救護切結書並詳實記錄
- (D) (D) 報請警察現場逮捕病患

011

站方自編，無考古題來源

救護車在執行緊急救護任務中，開啟警示燈及警鳴器時之交通行駛特權，下列敘述何者「錯誤」？

- (A) (A) 得不受行車速度之限制
- (B) (B) 得不受行車標誌、標線及號誌之限制
- (C) (C) 擁有絕對路權，即使發生車禍亦完全免除過失刑事與民事賠償責任
- (D) (D) 雖享有優先通行權，但仍應顧及其他車輛及行人安全（注意義務）

012

站方自編，無考古題來源

依現行《救護技術員管理辦法》，「協助使用吸入型支氣管擴張劑、自備腎上腺素注射筆或硝化甘油舌下含片」最低須為哪一級救護技術員才得施行？

- (A) (A) 初級救護技術員
- (B) (B) 中級救護技術員
- (C) (C) 高級救護技術員
- (D) (D) 各級救護技術員均不得施行

013

站方自編，無考古題來源

緊急醫療救護常規所指之「八大生命徵象 (Vital Signs)」，下列何者「不屬於」其中項目？

- (A) (A) 意識狀態 (Consciousness)
- (B) (B) 呼吸 (Respiration) 與脈搏 (Pulse)
- (C) (C) 體重 (Body Weight) 與尿量 (Urine Output)
- (D) (D) 血壓 (BP)、體溫 (BT)、瞳孔 (Pupil) 與膚色/微血管充填時間 (CRT)

014

站方自編，無考古題來源

正常健康成年人在安靜休息狀態下，其正常脈搏次數範圍通常為每分鐘幾次？

- (A) (A) 40~60 次/分
- (B) (B) 60~100 次/分
- (C) (C) 100~140 次/分
- (D) (D) 120~160 次/分

015

站方自編，無考古題來源

正常健康成年人於平靜休息時，每分鐘正常呼吸頻率範圍約為多少？

- (A) (A) 8~10 次/分
- (B) (B) 12~20 次/分
- (C) (C) 24~32 次/分
- (D) (D) 30~40 次/分

016

站方自編，無考古題來源

格拉斯哥昏迷指數 (Glasgow Coma Scale, GCS) 包含哪三大評估面向？其滿分與最低分分別為何？

- (A) (A) 脈搏、呼吸、血壓；滿分 100 分，最低 0 分
- (B) (B) 睜眼反應 (E)、語言反應 (V)、動作反應 (M)；滿分 15 分，最低 3 分
- (C) (C) 視覺、聽覺、觸覺；滿分 10 分，最低 1 分
- (D) (D) 瞳孔、膚色、肌力；滿分 12 分，最低 0 分

017

站方自編，無考古題來源

病患對呼喚聲音無反應，施予斜方肌痛刺激時，能「準確抬手撥開痛源」，此時其 GCS 之動作反應 (Motor, M) 應評為幾分？

- (A) (A) 6 分 (遵從指示動作)
- (B) (B) 5 分 (對痛能定位撥除)
- (C) (C) 4 分 (對痛僅有屈曲退縮)
- (D) (D) 3 分 (異常屈曲/去大腦皮質僵直)

018

站方自編，無考古題來源

創傷傷患睜眼需施以叫喚 (E3)、說話答非所問且字句混亂 (V3)、對疼痛刺激僅有四肢縮回反射 (M4)，其 GCS 總分應記為幾分？

- (A) (A) 8 分
- (B) (B) 10 分
- (C) (C) 12 分
- (D) (D) 14 分

019

站方自編，無考古題來源

評估傷病患微血管充填時間 (Capillary Refill Time, CRT) 時，正常回血時間應於幾秒之內完成？

- (A) (A) 1 秒內
- (B) (B) 2 秒內 (<2秒)
- (C) (C) 4 秒內
- (D) (D) 6 秒內

020

站方自編，無考古題來源

評估一名「意識清醒且呼吸正常」之成年傷病患時，最常優先觸診脈搏之動脈部位為何？

- (A) (A) 橈動脈 (Radial artery)
- (B) (B) 頸動脈 (Carotid artery)
- (C) (C) 股動脈 (Femoral artery)
- (D) (D) 足背動脈 (Dorsalis pedis artery)

021

站方自編，無考古題來源

針對一名「突然倒地、呼喚無反應且無呼吸」之成人傷患，救護員應於幾秒內觸摸何處動脈確認有無脈搏？

- (A) (A) 於 5~10 秒內觸摸橈動脈
- (B) (B) 於 5~10 秒內觸摸頸動脈
- (C) (C) 於 15~20 秒內觸摸股動脈
- (D) (D) 於 30 秒內觸摸足背動脈

022

站方自編，無考古題來源

評估「未滿一歲之嬰兒 (Infant)」心跳與脈搏時，建議首選之觸診動脈部位為何？

- (A) (A) 橈動脈
- (B) (B) 頸動脈
- (C) (C) 肱動脈 (Brachial artery)
- (D) (D) 顳動脈

023

站方自編，無考古題來源

以手電筒照射檢查傷患瞳孔對光反射時，發現「雙側瞳孔大小不一且一側固定放大對光無收縮」，最可能代表何種緊急狀況？

- (A) (A) 正常生理現象
- (B) (B) 鴉片類藥物中毒
- (C) (C) 嚴重的顱內壓升高 (IICP)、腦部出血或腦疝形成危急
- (D) (D) 低血糖反應

024

站方自編，無考古題來源

成人收縮壓 (Systolic BP) 低於多少 mmHg 時，臨床上通常被視為低血壓、組織灌流不足或休克之高危急指標？

- (A) (A) 120 mmHg
- (B) (B) 100 mmHg
- (C) (C) 90 mmHg
- (D) (D) 70 mmHg

025

站方自編，無考古題來源

人體負責調控呼吸頻率、心跳速率、血管張力等最原始自律生命機能之「生命中樞」，位於中樞神經系統之何處？

- (A) (A) 大腦皮質額葉
- (B) (B) 小腦蚓部
- (C) (C) 腦幹 (尤其是延腦)
- (D) (D) 脊髓腰椎節段

026

站方自編，無考古題來源

簡便意識評估量表「AVPU」中的「P」代表病患之意識反應層次為何？

- (A) (A) 完全清醒警覺 (Alert)
- (B) (B) 對口頭聲音有反應 (Voice)
- (C) (C) 僅對疼痛刺激有反應 (Pain)
- (D) (D) 對任何刺激均毫無反應 (Unresponsive)

027

站方自編，無考古題來源

對於「懷疑有頸椎受傷」或嚴重創傷機轉之病患，救護員暢通呼吸道之首選徒手手法為何？

- (A) (A) 壓額抬下巴法 (Head-tilt Chin-lift)
- (B) (B) 推下顎法 (Jaw-thrust maneuver)
- (C) (C) 頸部後仰過伸法 (Neck hyperextension)
- (D) (D) 側臥翻轉法

028

站方自編，無考古題來源

口咽呼吸道 (Oropharyngeal Airway, OPA) 之適當尺寸量測基準為何？

- (A) (A) 病患鼻尖至嘴角之距離
- (B) (B) 病患嘴角至耳垂 (或下頷角) 之距離
- (C) (C) 病患前額至鼻尖之距離
- (D) (D) 病患食指長度

029

站方自編，無考古題來源

使用口咽呼吸道（OPA）的最主要適應症與先決條件為何？

- (A) (A) 任何清醒且有氣喘之病患
- (B) (B) 任何有輕微咳嗽但呼吸急促之病患
- (C) (C) 病患「對疼痛刺激完全無反應（深昏迷）」且「無咽喉嘔吐反射（Gag reflex）」
- (D) (D) 僅限於氣管切開術之病患

030

站方自編，無考古題來源

為「成人」昏迷病患置入口咽呼吸道（OPA）之經典旋轉置入技巧為何？

- (A) (A) 凹面朝下直接筆直強行插入
- (B) (B) 凹面朝上置入口腔，抵達軟硬顎交界處時再旋轉 180 度順勢向下推入
- (C) (C) 凹面朝左側旋轉 360 度推入
- (D) (D) 必須在喉頭鏡直視下方可置入

031

站方自編，無考古題來源

鼻咽呼吸道（Nasopharyngeal Airway, NPA）長度之正確量取標準為何？

- (A) (A) 病患鼻尖至同側耳垂之距離
- (B) (B) 嘴角至下頷角之距離
- (C) (C) 兩側鼻孔間距
- (D) (D) 眉心至嘴角之距離

032

站方自編，無考古題來源

下列何種外傷病況被列為使用鼻咽呼吸道（NPA）之「絕對禁忌症」？

- (A) (A) 單純大腿閉鎖性骨折
- (B) (B) 懷疑顱底骨折（如鼻部或耳部流出清澈腦脊髓液 CSF、熊貓眼、耳後瘀斑）
- (C) (C) 意識昏迷但無任何頭部創傷
- (D) (D) 呼吸過快

033

站方自編，無考古題來源

使用抽吸器為「成人」清除口咽部異物或黏液時，單次抽吸時間「最長不可超過幾秒」？

- (A) (A) 5 秒
- (B) (B) 10 秒
- (C) (C) 15 秒
- (D) (D) 30 秒

034

站方自編，無考古題來源

使用抽吸管置入口腔與操作抽吸之正確原則為何？

- (A) (A) 插入時按住通氣孔持續抽吸
- (B) (B) 深度量測為鼻尖至下巴
- (C) (C) 插入時不可按住通氣孔（不抽吸），達到定位深度後，邊抽吸邊旋轉向外退出
- (D) (D) 抽吸越久越乾淨，應至少抽吸 45 秒以上

035

站方自編，無考古題來源

使用「鼻導管 (Nasal Cannula)」給氧時，其臨床建議設定之氧氣流量與提供之氧氣濃度 (FiO₂) 範圍為何？

- (A) (A) 流量 1~6 L/min；濃度約 24%~44%
- (B) (B) 流量 6~10 L/min；濃度約 40%~60%
- (C) (C) 流量 10~15 L/min；濃度約 80%~100%
- (D) (D) 流量 15~25 L/min；濃度約 100%

036

站方自編，無考古題來源

使用「非再吸入型面罩 (Non-rebreathing Mask, NRM)」進行高濃度給氧時，建議氧氣流量為何？使用前必須注意何項步驟？

- (A) (A) 流量 2~4 L/min；無須理會儲氣袋
- (B) (B) 流量 6~10 L/min；將儲氣袋排空
- (C) (C) 流量 10~15 L/min；戴上病患臉部前，必須先以手堵住呼氣閥使儲氣袋充飽至少 2/3 以上
- (D) (D) 流量 20~30 L/min；儲氣袋不可進氣

037

站方自編，無考古題來源

使用袋瓣罩甦醒球 (BVM) 搭配面罩為無呼吸成人病患進行正壓人工通氣時，面罩應如何密合固定？

- (A) (A) 面罩尖端朝向下巴，單手隨意按壓
- (B) (B) 面罩尖端朝向鼻樑，以「EC 手勢」（拇指與食指呈C型壓緊面罩，中指、無名指、小指呈E型托住下頷骨）確實緊貼
- (C) (C) 面罩橫放蓋住雙眼與嘴巴
- (D) (D) 無須密合，保留大縫隙通風

038

站方自編，無考古題來源

袋瓣罩甦醒球 (BVM) 連接氧氣並使用儲氣袋時，氧氣流量計通常應設定調至多少 L/min？

- (A) (A) 4 L/min
- (B) (B) 8 L/min
- (C) (C) 15 L/min
- (D) (D) 25 L/min

039

站方自編，無考古題來源

緊急救護常用的「D型 (D-cylinder)」可攜式氧氣鋼瓶，其鋼瓶轉換常數為何？安全存量通常保留多少 psi？

- (A) (A) 常數 0.16；安全存量 200 psi
- (B) (B) 常數 0.28；安全存量 500 psi
- (C) (C) 常數 1.56；安全存量 100 psi
- (D) (D) 常數 3.14；安全存量 1000 psi

040

站方自編，無考古題來源

一具壓力表顯示 1200 psi 的 D 型氧氣鋼瓶（常數 0.16，安全存量 200 psi），若設定非再吸入型面罩流量為 10 L/min，該氧氣瓶大約還可連續使用幾分鐘？

- (A) (A) 約 8 分鐘 (B) (B) 約 16 分鐘
(C) (C) 約 25 分鐘 (D) (D) 約 40 分鐘

041

站方自編，無考古題來源

成人單純換氣不足但有脈搏時，以 BVM 進行純人工呼吸通氣之給氣頻率為何？每次給氣時間約多久？

- (A) (A) 每 2~3 秒給一口氣；每次給氣 3 秒
(B) (B) 每 5~6 秒給一口氣（每分鐘約 10~12 次）；每次給氣約 1 秒，以胸廓微微起伏為準
(C) (C) 每 10 秒給一口氣；每次給氣 0.5 秒
(D) (D) 每 1 秒給一口氣（每分鐘 60 次）

042

站方自編，無考古題來源

成人「院外心臟停止（OHCA）」生存之鏈（Chain of Survival）六大環節依序為何？

- (A) (A) 快速送醫 → 醫師診斷 → 開刀 → 服藥 → 復健 → 出院
(B) (B) 早期辨識與求救（119）→ 高品質 CPR → 快速去顫（AED）→ 高級救命術（ACLS）→ 心臟驟停後照護 → 復原（Recovery）
(C) (C) 施行人工呼吸 → 靜脈注射 → 電擊 → 止血 → 包紮 → 搬運
(D) (D) 測量血壓 → 抽血 → 胸外按壓 → 氣管插管 → 保溫 → 送醫

043

站方自編，無考古題來源

執行高品質成人 CPR 時，胸外心臟按壓的「正確深度」與「按壓速率」分別應符合何項標準？

- (A) (A) 深度 3~4 公分；速率 80~100 次/分
(B) (B) 深度 5~6 公分；速率 100~120 次/分
(C) (C) 深度 7~8 公分；速率 120~140 次/分
(D) (D) 深度至少 10 公分；速率越高越好

044

站方自編，無考古題來源

成人施行心肺復甦術時，無論是「單人施救」或「雙人救護員」，其胸外按壓與人工呼吸之比例均應為何？

- (A) (A) 15 : 2 (B) (B) 30 : 2
(C) (C) 5 : 1 (D) (D) 50 : 2

045

站方自編，無考古題來源

針對「兒童（Child）」或「嬰兒（Infant）」心臟驟停，由「雙人救護員」施行 CPR 時，其胸外按壓與人工呼吸比率應調整為何？

- (A) (A) 30 : 2 (B) (B) 15 : 2
(C) (C) 5 : 1 (D) (D) 15 : 1

046

站方自編，無考古題來源

自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 語音發出「建議電擊 (Shock Advised)」指令時，代表傷患此時心律最可能處於何種致命狀態？

- (A) (A) 心室纖維顫動 (VF) 或無脈性心室頻脈 (Pulseless VT)
- (B) (B) 心搏停止 (Asystole)
- (C) (C) 無脈性電氣活動 (PEA)
- (D) (D) 竇性心律過緩 (Sinus Bradycardia)

047

站方自編，無考古題來源

下列何種心律 AED 會分析判定為「不建議電擊 (No Shock Advised)」？此時應立即採取何種行動？

- (A) (A) 心室纖維顫動 (VF)；應等待醫師抵達
- (B) (B) 心搏停止 (Asystole) 或無脈性電氣活動 (PEA)；應立即重新實施 CPR 胸外按壓
- (C) (C) 無脈性心室頻脈；應拔掉貼片收工
- (D) (D) 任何心律均需電擊

048

站方自編，無考古題來源

AED 成人電擊貼片之標準黏貼位置為何？

- (A) (A) 左胸上方與腹部臍周
- (B) (B) 右胸上方（右鎖骨下方）與左胸外下方（左乳頭外側下緣、腋中線）
- (C) (C) 背部左右肩胛骨
- (D) (D) 前後胸壁正中心點

049

站方自編，無考古題來源

當 AED 充能完畢並發出蜂鳴聲準備電擊時，施救者在按下電擊鈕前必須大聲喊出並確認何事？

- (A) (A) 「大家用力壓胸」
- (B) (B) 「我離開、你離開、大家都離開（嚴禁任何人觸碰傷患）」並確認無人碰觸
- (C) (C) 「快給一口氣」
- (D) (D) 「關閉 AED 電源」

050

站方自編，無考古題來源

AED 電擊完成後，救護員第一時間應立即採取何種行動？

- (A) (A) 停下來檢查病患脈搏 1 分鐘
- (B) (B) 拔掉 AED 電擊貼片並關機
- (C) (C) 無須花時間摸脈搏，立即重新開始 CPR 胸外按壓 2 分鐘（5個循環）
- (D) (D) 將病患扶起坐好

051

站方自編，無考古題來源

心室纖維顫動 (VF) 傷患若無施予 CPR，每延遲去顫電擊 1 分鐘，其存活率估計大約下降多少？

- (A) (A) 1%~2%
- (B) (B) 3%~4%
- (C) (C) 7%~10%
- (D) (D) 20%~25%

052

站方自編，無考古題來源

一名清醒成年男性用餐時突然雙手抓掐喉嚨、表情痛苦發不出聲音、無法咳嗽，此為呼吸道異物嚴重哽塞徵象，首選處置為何？

- (A) (A) 立即給予一大杯水要求其吞下
- (B) (B) 站在病患身後，實施「哈姆立克法 (Heimlich Maneuver / 腹部向上推擠法)」
- (C) (C) 用手指盲目深入口腔深部挖取
- (D) (D) 叫病患躺下實施長背板固定

053

站方自編，無考古題來源

若異物哽塞病患為「懷孕後期之明顯孕婦」或「重度肥胖者」，施救者應改採何種手法推擠排出異物？

- (A) (A) 改採「胸部推擠法 (Chest Thrusts)」於胸骨下半段施壓
- (B) (B) 用力重擊腹部肚臍下方
- (C) (C) 倒立懸掛拍打雙腳
- (D) (D) 嚴禁急救，靜待救護車

054

站方自編，無考古題來源

嚴重異物哽塞病患在處置過程中「突然失去意識倒地」，施救者應立即如何調整急救程序？

- (A) (A) 繼續站著實施哈姆立克推擠
- (B) (B) 將病患安全放倒於平坦堅硬地面上，立即啟動 CPR 胸外按壓 30 次，每次吹氣前檢查口腔有無可見異物
- (C) (C) 立即猛掐人中等待甦醒
- (D) (D) 放棄急救

055

站方自編，無考古題來源

針對未滿 1 歲之清醒「嬰兒 (Infant)」發生嚴重呼吸道異物哽塞時，正確急救操作手法為何？

- (A) (A) 實施成人哈姆立克腹部推擠
- (B) (B) 趴在施救者前臂頭低腳高「拍背 5 次」，隨後翻轉正面實施「壓胸 5 次」，交替操作
- (C) (C) 盲目以食指伸入喉部深處搜尋異物
- (D) (D) 用力搖晃嬰兒全身

056

站方自編，無考古題來源

使用 AED 時，若傷患胸前裝有「心律調節器 (Pacemaker)」導致皮下有明顯硬塊突起，電擊貼片應如何處理？

- (A) (A) 正對調節器金屬硬塊緊密重疊黏貼
- (B) (B) 避開該凸起硬塊，至少距離調節器 2.5 公分 (約 1 吋) 以上位置黏貼
- (C) (C) 嚴禁使用 AED 電擊
- (D) (D) 將調節器硬塊切開取出

057

站方自編，無考古題來源

創傷病患初評流程中，國際與台灣急救指引強調「XABCDE」架構，其中字首「X」代表何項最優先處置項目？

- (A) (A) X光攝影 (X-ray)
- (B) (B) 控制致命性大出血 (eXsanguinating hemorrhage)
- (C) (C) 頸椎完全固定 (X-collar)
- (D) (D) 心理輔導 (X-mind)

058

站方自編，無考古題來源

針對四肢噴射性嚴重動脈出血，一般「直接加壓止血」無效時，應立即採取何種最有效止血手段？

- (A) (A) 患肢抬高於心臟即可
- (B) (B) 於傷口近心端 5~7 公分處施打戰術止血帶 (CAT) 並旋緊絞棒至遠端脈搏摸不到、出血停止
- (C) (C) 用大量冷水沖洗傷口
- (D) (D) 冰敷患部

059

站方自編，無考古題來源

在現場為傷患施打戰術止血帶 (CAT) 後，救護員必須嚴格遵守之重要原則為何？

- (A) (A) 必須在止血帶白色時間標籤上清楚註記「施打時間 (TIME)」，且到院前「嚴禁自行鬆開」
- (B) (B) 每隔 15 分鐘必須自行鬆開 5 分鐘通血
- (C) (C) 止血帶應以厚衣物完全包裹遮蓋不讓醫院人員看見
- (D) (D) 止血帶打上後遠端脈搏越強越好

060

站方自編，無考古題來源

頭部鈍傷病患檢查發現「雙眼眶周圍嚴重瘀青 (熊貓眼 Raccoon eyes)」或「耳後乳突處瘀斑 (Battle's sign)」，高度代表何種骨折？

- (A) (A) 下頷骨骨折
- (B) (B) 鎖骨骨折
- (C) (C) 顱底骨折 (Basilar Skull Fracture)
- (D) (D) 頸椎第二節骨折

061

站方自編，無考古題來源

胸部穿刺傷合併「吮吸性胸部傷口 (開放性氣胸 Sucking chest wound)」，現場敷料包紮之黃金處置原則為何？

- (A) (A) 四邊全部以透氣膠帶貼死
- (B) (B) 使用不透氣敷料 (如凡士林紗布或塑膠包裝) 覆蓋，並「三邊貼緊、留下一邊開放」形成單向活瓣
- (C) (C) 將傷口撐開通風
- (D) (D) 嚴禁覆蓋任何敷料

062

站方自編，無考古題來源

腹部創傷導致腸道等臟器脫出體外（Evisceration）時，現場正確處置方式為何？

- (A) (A) 立即戴手套用力將脫出的腸子全部塞回腹腔內
- (B) (B) 嚴禁推回臟器，應以「無菌生理食鹽水濕紗布」覆蓋保濕，外層加覆防水膜或保鮮膜保溫後迅速送醫
- (C) (C) 使用乾紗布直接按壓止血
- (D) (D) 塗抹大量抗生素藥膏

063

站方自編，無考古題來源

傷患胸壁或大腿遭鋼筋、尖刀等異物深刺穿留體內（Impalement），現場處置原則為何？

- (A) (A) 迅速將穿刺物用力拔除以利傷口消毒
- (B) (B) 嚴禁拔除穿刺物，應以敷料或捲軸紗布在穿刺物四周穩固固定，避免移動造成二次大出血
- (C) (C) 左右搖晃穿刺物以測試深度
- (D) (D) 於穿刺物末端用力敲擊

064

站方自編，無考古題來源

意外斷肢（如手指或手掌完全截斷）時，現場對於「離斷肢體」之正確保存運送原則為何？

- (A) (A) 直接將斷肢浸泡在純酒精或熱水中消毒
- (B) (B) 將斷肢直接埋入純冰塊或乾冰中冷凍
- (C) (C) 以生理食鹽水微濕無菌紗布包裹斷肢，裝入乾淨密封防水塑膠袋，再將塑膠袋置於「冰水混合物」容器中隔水冷藏（嚴禁直接接觸冰塊）
- (D) (D) 隨意丟入垃圾袋中

065

站方自編，無考古題來源

對肢體長骨折實施夾板包紮固定時，夾板長度與固定範圍應遵循何項基本原則？

- (A) (A) 夾板長度只需覆蓋骨折局部傷口即可
- (B) (B) 夾板長度必須超越骨折處之「上下兩個鄰近關節」並予以有效固定
- (C) (C) 夾板必須固定全身所有關節
- (D) (D) 關節處骨折只需固定單一骨幹

066

站方自編，無考古題來源

在對患肢進行副木夾板固定「之前」與「之後」，救護人員均必須重複評估肢體末端的何項神經血管指標？

- (A) (A) 體重與身高
- (B) (B) CMS 評估（Circulation 血液循環/脈搏、Motor 運動功能、Sensory 感覺功能）
- (C) (C) 瞳孔對光反射
- (D) (D) 腹部敲診音

067

站方自編，無考古題來源

測量硬頸圈（C-spine Collar）之尺寸大小時，救護員手指定位測量病患頸部之解剖基準點為何？

- (A) (A) 頭頂至鼻尖垂直高度
- (B) (B) 病患「下頷骨下緣假想水平線」至「斜方肌前緣（肩部基部）」之間的垂直手指寬度
- (C) (C) 喉結至胸骨柄之距離
- (D) (D) 兩側耳垂之間的水平距離

068

站方自編，無考古題來源

使用長背板固定創傷傷患時，軀幹固定帶綁紮與頭部固定器（Head Immobilizer）固定之先後順序原則為何？

- (A) (A) 先固定頭部，最後綁胸部
- (B) (B) 先固定軀幹及四肢約束帶（胸、髖/骨盆、大腿/膝），「頭部頸部固定器最後固定」
- (C) (C) 隨便先綁哪裡都可以
- (D) (D) 僅固定雙腳即可

069

站方自編，無考古題來源

高處墜落疑似脊椎受傷之清醒傷患，在現場若主訴頸部劇烈疼痛，救護人員接觸病患之第一動作應為何？

- (A) (A) 扶起患者坐立飲水
- (B) (B) 立即以雙手施行「頭頸部徒手胸頸中立固定（Manual in-line stabilization）」並指示病患切勿轉頭
- (C) (C) 左右劇烈轉動病患頸部檢查活動度
- (D) (D) 脫去其安全帽並拋擲

070

站方自編，無考古題來源

在狹窄彎曲的公寓樓梯間運送無頸椎創傷之清醒心臟衰竭或氣喘呼吸困難病患時，最適合選用的搬運器材為何？

- (A) (A) 長背板（Long Spine Board）
- (B) (B) 樓梯搬運椅（Stair Chair）
- (C) (C) 帆布擔架
- (D) (D) 籃式擔架

071

站方自編，無考古題來源

重大車禍現場，汽車已起火燃燒威脅傷患生命，單人救護員需在數秒內緊急將無意識傷患移出車外，應採用何種緊急移位技術？

- (A) (A) 慢慢等待消防隊員架設水線
- (B) (B) 立即採用「緊急移位法（如單人腋下拖拉法 Rapid Extrication）」迅速拉離危險區域
- (C) (C) 現場慢慢量測硬頸圈與包紮小傷口
- (D) (D) 等待吊車抵達

072

站方自編，無考古題來源

院前辛辛那提腦中風指標 (Cincinnati Prehospital Stroke Scale, CPSS) 包含哪三大測試項目？

- (A) (A) 體溫、脈搏、血壓
- (B) (B) 顏面下垂 (Facial Droop)、手臂下垂飄移 (Arm Drift)、言語異常 (Abnormal Speech)
- (C) (C) 瞳孔大小、對光反射、角膜反射
- (D) (D) 膝反射、巴賓斯基反射、跟腱反射

073

站方自編，無考古題來源

急性心肌梗塞 (Acute Myocardial Infarction, AMI) 發作時，病患最典型之胸痛臨床特徵為何？

- (A) (A) 胸口劇烈壓迫感、如大石重壓，且常輻射至左肩、左臂內側、下巴或背部，休息常無法緩解
- (B) (B) 隨呼吸深淺出現刺痛，按壓胸肋骨會劇烈疼痛
- (C) (C) 僅有下腹部絞痛與腹瀉
- (D) (D) 喝一杯冰開水後即可完全改善

074

站方自編，無考古題來源

糖尿病病患發生急性「低血糖 (Hypoglycemia)」時，若病患「意識清楚、能自行吞嚥且配合」，現場第一步急救處置為何？

- (A) (A) 立即強迫注射大劑量胰島素
- (B) (B) 口服給予 15~20 克易吸收糖分 (如含糖果汁、汽水、糖果或方糖)
- (C) (C) 嚴禁口服任何東西，叫其跑步運動
- (D) (D) 施予心臟胸外按壓

075

站方自編，無考古題來源

遇一名糖尿病病患「意識昏迷、呼喚無反應」，救護人員在處置上何者為「絕對嚴禁」之危險舉動？

- (A) (A) 測量微血管血糖值 (Dextrostix)
- (B) (B) 維持呼吸道暢通並給予氧氣
- (C) (C) 嚴禁強行從病患嘴巴灌入糖水、蜂蜜或固體食物
- (D) (D) 監測生命徵象並迅速送醫

076

站方自編，無考古題來源

氣喘 (Asthma) 或慢性阻塞性肺病 (COPD) 急性發作時，聽診肺部最常聽到的異常呼吸音為何？

- (A) (A) 呼氣性高頻哮鳴音 / 喘鳴音 (Wheezing)
- (B) (B) 正常清晰肺泡呼吸音
- (C) (C) 打呼鼾聲 (Snoring)
- (D) (D) 羊鳴音

077

站方自編，無考古題來源

蜂螫或藥物引發嚴重「過敏性休克 (Anaphylaxis)」導致喉頭水腫、低血壓與全身蕁麻疹，急救醫療體系首選之關鍵救命藥物為何？

- (A) (A) 口服普拿疼 (Acetaminophen)
- (B) (B) 肌肉注射腎上腺素 (Epinephrine, 1:1000)
- (C) (C) 胰島素
- (D) (D) 抗生素

078

站方自編，無考古題來源

臨床上「休克 (Shock)」之核心病理生理定義為何？

- (A) (A) 單純心理受到極大驚嚇
- (B) (B) 全身各組織與器官血液灌流量不足，導致細胞缺氧及代謝廢物堆積
- (C) (C) 血糖過高引發多尿
- (D) (D) 關節滑液分泌過多

079

站方自編，無考古題來源

外傷失血性休克（無頭部外傷、胸部創傷或脊椎損傷疑慮）時，現場標準之病患休克臥位（Shock position）為何？

- (A) (A) 頭高腳低坐姿
- (B) (B) 平躺並將「下肢抬高約 20~30 公分」
- (C) (C) 趴睡俯臥
- (D) (D) 倒立懸掛

080

站方自編，無考古題來源

針對疑似「急性心肌梗塞併發肺水腫、心因性休克、端坐呼吸」之病患，何種體位為「絕對禁忌」？

- (A) (A) 半坐臥位 (Fowler's position)
- (B) (B) 嚴禁抬高下肢（嚴禁平躺抬腳）
- (C) (C) 身體微向前傾坐姿
- (D) (D) 給予高濃度氧氣

081

站方自編，無考古題來源

依據成人燒燙傷「九則計算法 (Rule of Nines)」，成人「整個頭頸部」與「一整隻單側下肢」所佔全身表面積 (TBSA) 百分比分別為何？

- (A) (A) 頭頸部 9%；單側下肢 18%
- (B) (B) 頭頸部 18%；單側下肢 9%
- (C) (C) 頭頸部 4.5%；單側下肢 9%
- (D) (D) 頭頸部 1%；單側下肢 36%

082

站方自編，無考古題來源

燒傷侵及真皮層，局部皮膚紅腫、劇烈疼痛且出現明顯「大小水泡 (Blisters)」，臨床深度分級為何？

- (A) (A) 一度燒燙傷 (Superficial)
- (B) (B) 二度燒燙傷 (Partial Thickness)
- (C) (C) 三度燒燙傷 (Full Thickness)
- (D) (D) 四度燒燙傷

083

站方自編，無考古題來源

小面積熱液燙傷現場處理原則「沖、脫、泡、蓋、送」，其中「沖」之正確操作方式為何？

- (A) (A) 用大量冰塊直接重壓冰敷傷口 1 小時
- (B) (B) 以乾淨流動冷水 (15~20°C) 輕柔沖洗傷口約 15~30 分鐘降溫
- (C) (C) 沖洗高壓熱水
- (D) (D) 塗抹大量醬油或牙膏

084

站方自編，無考古題來源

成功嶺新訓夏日酷暑高溫演訓時，鑑別「熱衰竭 (Heat Exhaustion)」與致命「熱中暑 (Heat Stroke)」的最核心關鍵指標為何？

- (A) (A) 是否有流口水
- (B) (B) 熱中暑病患出現「中樞神經功能異常 (意識混亂、譫妄、昏迷抽搐)」且「核心體溫高達 40°C 以上」，常皮膚乾熱無汗
- (C) (C) 兩者完全無區別
- (D) (D) 僅看脈搏有無跳動

085

站方自編，無考古題來源

針對急性致命熱中暑 (Heat Stroke) 昏迷傷患，現場最關鍵、最具決定性的救命急救行動為何？

- (A) (A) 給予大量熱開水慢飲
- (B) (B) 立即將傷患移至陰涼通風處，解開全身衣物，全身噴灑冷水並強力吹風搧風進行「積極蒸發散熱降溫」
- (C) (C) 裹上厚厚棉被強迫其排汗
- (D) (D) 靜待其自然降溫

086

站方自編，無考古題來源

野外或營區操課遇毒蛇咬傷時，下列現場急救處置何者為「絕對嚴禁執行之危險錯誤行為」？

- (A) (A) 保持冷靜，去除傷肢的手錶戒指等束縛物
- (B) (B) 以清水或肥皂水溫和沖洗傷口，並使患肢維持於低於心臟之高度
- (C) (C) 用嘴巴吸吮毒液、用刀片切開傷口放血、或用冰塊局部冰敷
- (D) (D) 記住蛇類外觀特徵或拍照以便醫師辨識血清

087

站方自編，無考古題來源

國際大量傷病患 START (Simple Triage and Rapid Treatment) 檢傷分類法中，第一步驟要求「所有能自己走動的人員前往指定安全區集合」，這批傷患直接被歸類為何種檢傷標籤？

- (A) (A) 紅色 (第一優先, 極重傷 Immediate)
- (B) (B) 黃色 (第二優先, 中傷 Delayed)
- (C) (C) 綠色 (第三優先, 輕傷 Minor)
- (D) (D) 黑色 (死亡或無存活希望 Expectant)

088

站方自編，無考古題來源

START 檢傷分類中，評估不能走動傷患發現其「無呼吸」，施救者立即實施壓額抬下巴暢通呼吸道後「依然沒有呼吸」，此傷患應歸類為何種顏色標籤？

- (A) (A) 紅色
- (B) (B) 黃色
- (C) (C) 綠色
- (D) (D) 黑色 (死亡或無存活希望 Expectant / Deceased)

089

站方自編，無考古題來源

START 檢傷分類中，原先無呼吸之傷患，在救護員「暢通呼吸道後立即恢復自主呼吸」，此時應立即掛上何種顏色檢傷標籤？

- (A) (A) 紅色 (第一優先, 極重傷 Immediate)
- (B) (B) 黃色
- (C) (C) 綠色
- (D) (D) 黑色

090

站方自編，無考古題來源

START 檢傷分類中，不能走動且有自主呼吸的傷患，其呼吸速率大於每分鐘幾次 (RR) 時，直接判定為「紅色」重傷？

- | | |
|------------------|------------------|
| (A) (A) > 12 次/分 | (B) (B) > 20 次/分 |
| (C) (C) > 30 次/分 | (D) (D) > 50 次/分 |

091

站方自編，無考古題來源

START 檢傷分類中，傷患呼吸速率 22 次/分 (<30次)，接著評估血液灌流，若「摸不到橈動脈」或「微血管充填時間 (CRT) > 2 秒」，該傷患應歸類為何者？

- (A) (A) 紅色 (第一優先 Immediate)
- (B) (B) 黃色
- (C) (C) 綠色
- (D) (D) 黑色

092

站方自編，無考古題來源

傷患呼吸 20 次/分、橈動脈明顯且有力、CRT < 2 秒，但對救護員口頭簡單指令（如「請眨眼」或「捏緊我的手」）「完全無法遵循配合（意識障礙）」，其檢傷等級應為何？

- (A) (A) 紅色（第一優先 Immediate）
- (B) (B) 黃色（第二優先 Delayed）
- (C) (C) 綠色（第三優先 Minor）
- (D) (D) 黑色

093

站方自編，無考古題來源

傷患因大腿閉鎖性骨折無法行走，檢查呼吸 18 次/分、橈動脈搏動正常、CRT 1.5 秒、意識清楚且能聽從指令，其檢傷等級應為何？

- (A) (A) 紅色
- (B) (B) 黃色（第二優先，中傷 Delayed）
- (C) (C) 綠色
- (D) (D) 黑色

094

站方自編，無考古題來源

在大量傷病患（MCI）災害現場，START 檢傷人員對「每一位」傷患的檢傷分類評估時間，原則上應控制在多久之內？

- (A) (A) 30 秒至 1 分鐘以內
- (B) (B) 至少 5~10 分鐘進行全身詳細檢查
- (C) (C) 至少 15 分鐘
- (D) (D) 30 分鐘

095

站方自編，無考古題來源

救護技術員抵達各類車禍或災害事故現場，在接近任何傷患之前的「第一法定與安全行動」應為何？

- (A) (A) 立即衝上前抱起傷患狂奔
- (B) (B) 現場環境安全評估（Scene Size-up），確認無燃油外洩、高壓電線掉落或二次車禍威脅，確保自身防護安全
- (C) (C) 立即拿出相機拍照發上社群網站
- (D) (D) 大聲斥責圍觀民眾

096

站方自編，無考古題來源

依《緊急醫療救護法》第32條，直轄市、縣（市）政府遇大量傷病患或野外緊急救護時，應依災害規模及種類建立什麼，以施行救護有關工作？

- (A) (A) 臨時福利社
- (B) (B) 現場指揮協調系統
- (C) (C) 臨時法庭
- (D) (D) 民宿接待處

答案速查

「—」表示舊制或條件衝突，不作現行計分；「†」表示答案尚待完整核實，請以當梯授課與現行法規為準。

001	C	002	C	003	B	004	D	005	D	006	B	007	B	008	C	009	B	010	C†
011	C†	012	B	013	C†	014	B†	015	B†	016	B†	017	B†	018	B†	019	B†	020	A†
021	B†	022	C†	023	C†	024	C†	025	C†	026	C†	027	B†	028	B†	029	C†	030	B†
031	A†	032	B†	033	C†	034	C†	035	A†	036	C†	037	B†	038	C†	039	A†	040	B†
041	B†	042	B†	043	B†	044	B†	045	B†	046	A†	047	B†	048	B†	049	B†	050	C†
051	C†	052	B†	053	A†	054	B†	055	B†	056	B†	057	B†	058	B†	059	A†	060	C†
061	B†	062	B†	063	B†	064	C†	065	B†	066	B†	067	B†	068	B†	069	B†	070	B†
071	B†	072	B†	073	A†	074	B†	075	C†	076	A†	077	B†	078	B†	079	B†	080	B†
081	A†	082	B†	083	B†	084	B†	085	B†	086	C†	087	C†	088	D†	089	A†	090	C†
091	A†	092	A†	093	B†	094	A†	095	B†	096	B								